

10_email_ehemann.eml

Von	samir.tunc@privatpost.de
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Tue, 30 Jun 2026 22:41:00 +0200
Betreff	Therapieslot und Angst vor Kosten

Guten Abend,

Leyla will nicht, dass wir alles verkaufen für ein Medikament, das vielleicht nicht wirkt. Gleichzeitig sagt die Klinik, dass wir das Fenster nicht verpassen dürfen. Ich brauche eine klare Liste, was das Gericht vor dem 18. Juli wirklich sehen muss.

Bitte sagen Sie auch, welche Unterlagen von der Schule wichtig sind. Leyla versucht noch Korrekturen zu machen, aber sie kann kaum 20 Minuten lesen.

Viele Grüße

Samir Tunc

14_email_klinikapotheke_beschaffung_und_kosten.eml

Von	Klinikapotheke Mainz <sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de>
An	"Prof. Dr. Miriam Strauß" <m.strauss@unimedizin-mainz.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 13:54:00 +0200
Betreff	UM 26-NI-4471 - Neravexor Lieferfenster und Preisbestätigung

Sehr geehrte Frau Professor Strauß, der Hersteller hat für eine Einzeldosis Neravexor einen Nettopreis von 480000 Euro zuzüglich Transport und Kühlkettenmonitoring bestätigt. Die Reservierung gilt bis 17. Juli 12 Uhr. Danach wird die Charge anderweitig vergeben. Eine Rückgabe nach Freigabe des Transports ist ausgeschlossen.

Die Lieferung könnte frühestens am 27. Juli eintreffen. Das Präparat muss zwischen zwei und acht Grad gelagert und innerhalb von 36 Stunden nach Entnahme aus der Transportbox verwendet werden. Für die Zubereitung benötigen wir die endgültige Dosisberechnung, das aktuelle Gewicht und die schriftliche Kostenfreigabe. Eine Bestellung ist bislang nicht ausgelöst worden.

Der Hersteller hat außerdem ein Registerformular und die Meldung jeder schwerwiegenden Reaktion verlangt. Bitte klären Sie, wer die Dokumentation übernimmt. Frau Mäßler aus der Apotheke hat am Montag Dienst und kann die Kühlkette mit der Station abstimmen. Diese Mail bestätigt nur Preis und Logistik, nicht die medizinische Eignung.

Freundliche Grüße
Klinikapotheke Mainz
sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie
Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor
Unser Zeichen: UM 26-NI-4471
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

04_kostenplan_apotheke.csv

position	menge	kosten_eur	notiz
Neravexor Dosis 1	1	480000	Import und Zubereitung
Stationäre Überwachung Dosis 1	1	12500	3 Tage
Neravexor Dosis 2	1	480000	8 Wochen später
Stationäre Überwachung Dosis 2	1	12500	3 Tage
Begleitdiagnostik	2	7800	MRT Labor Liquor

15_verlauf_labor_gehstrecke_2025_2026.csv

■Datum	Gehstrecke_M eter	Hilfsmittel	ALT_U_I	AST_U_I	Therapie	Beobachtung
2025-01-14	420	keins	31	28	Therapie A	leichte Fatigue
2025-08-22	260	Gehstock	36	33	Therapie A	zwei Stürze
2026-02-18	170	Rollator	288	241	Therapie B beendet	Leberwerte erhöht
2026-05-11	110	Rollator	48	42	keine Basistherapie	erste Schlucks törung
2026-06-29	85	Rollstuhl außen	39	35	Planung Neravexor	Fallboard erfolgt

Mandatsnotiz Eilverfahren Off-Label-Use

1. Mandantin

Mandantin ist Leyla Tunc, geboren am 16.11.1991, Grundschullehrerin aus Mainz. Diagnose: progrediente Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil, Schübe seit 2024, deutliche Gang- und Sehstörungen, kognitive Erschöpfung. Krankenkasse: RheinMain BKK.

2. Beantragte Behandlung

Universitätsmedizin Mainz beantragt Neravexor, ein monoklonales Antikörperpräparat, zugelassen für eine andere seltene neuroimmunologische Indikation. Für Leylas Erkrankung besteht keine deutsche Zulassung. Klinik schlägt zwei Dosen im Abstand von acht Wochen vor. Kosten laut Klinikapotheke: 480.000 EUR je Dosis einschließlich Zubereitung und stationärer Überwachung.

3. Verfahren

Antrag der Klinik 07.06.2026. MD-Gutachten 20.06.2026. Ablehnungsbescheid 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Geplanter stationärer Slot 18.07.2026. Widerspruch und Eilantrag müssen parallel vorbereitet werden.

4. Rentenberaterliche Perspektive

Kurzfristig Krankenversicherungsanspruch und Eilrechtsschutz. Parallel: Krankengeld, Reha, mögliche Erwerbsminderung, Schwerbehindertenverfahren und dienstrechtliche Fragen nur koordinierend. Die Akte darf medizinische Hoffnung nicht mit rechtlicher Erfolgsaussicht verwechseln; die drei Off-Label-Kriterien müssen materialgestützt abgearbeitet werden.

Klinikantrag Universitätsmedizin Mainz

1. Medizinischer Stand

Die Patientin leidet an einer rasch progredienten Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil. Standardtherapien mit hochdosierten Steroiden, Plasmapherese, Rituximab und Cyclophosphamid führten nur zu vorübergehender Stabilisierung. Seit Mai 2026 neue Herde im MRT und Verschlechterung der Gehstrecke auf unter 200 Meter.

2. Behandlungsziel

Neravexor soll die Krankheitsprogression stoppen oder verlangsamen, Schubaktivität senken und den Verlust selbständiger Gehfähigkeit verhindern. Eine Heilung wird nicht versprochen. Die Klinik hält eine palliative und stabilisierende Wirkung für realistisch.

3. Evidenzmaterial

Die Klinik legt eine Phase-II-Studie zur verwandten Antikörpergruppe, zwei Fallserien, ein Registersignal und eine Stellungnahme des europäischen Referenzzentrums vor. Eine Phase-III-Studie für exakt diese Indikation existiert nicht. Die Klinik argumentiert mit Seltenheit, Pathomechanismus und fehlender Alternative.

MD-Gutachten, Auszug

1. Ergebnis

Der MD empfiehlt Ablehnung der Kostenübernahme. Es liege ein Off-Label-Use außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung vor. Eine Empfehlung in der Arzneimittel-Richtlinie sei nicht ersichtlich. Für die konkrete Indikation fehle eine hochwertige Studie mit klinisch relevantem Nutzen.

2. Anerkannte Punkte

Der MD erkennt die Schwere der Erkrankung und die erhebliche Teilhabebeeinträchtigung an. Standardtherapien seien weitgehend ausgeschöpft. Gleichwohl sei der Nutzen von Neravexor für diese Indikation nicht hinreichend belegt.

3. Angriffspunkte

Das Gutachten setzt sich nur knapp mit der Registerauswertung und der Stellungnahme des Referenzzentrums auseinander. Es prüft nicht ausdrücklich, ob eine notstandsähnliche Situation nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V in Betracht kommt. Für den Eilantrag braucht es eine ärztliche Zusatzstellungnahme zu Prognose ohne Behandlung.

Arbeitsnotiz Studienlage

1. Material der Klinik

Die Klinik legt keine Phase-III-Studie für exakt Leylas Indikation vor. Vorhanden sind eine kleine kontrollierte Phase-II-Studie bei verwandter Erkrankung, zwei Fallserien mit insgesamt 19 Patienten, ein Registersignal und ein Expertenbrief. Das Material ist medizinisch ernst zu nehmen, rechtlich aber angreifbar.

2. Rechtliche Sortierung

Für den allgemeinen Off-Label-Use werden typischerweise schwere Erkrankung, fehlende Therapiealternative und begründete Erfolgsaussicht verlangt. Bei notstandsähnlicher Lage nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V kann die Prüfung anders akzentuiert sein, bleibt aber nicht evidenzfrei. Der Schriftsatz muss beides trennen.

3. Benötigte Ergänzung

Die Klinik soll bis 06.07.2026 beantworten: Wie schnell droht irreversible Verschlechterung? Welche Standardtherapie ist konkret ausgeschöpft? Welche objektiven Marker sprechen für Neravexor? Welches Risiko entsteht durch Abwarten bis Hauptsacheentscheidung?

Ablehnungsbescheid RheinMain BKK

1. Entscheidung

Die Kostenübernahme für Neravexor wird abgelehnt. Die beantragte Behandlung sei nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung für die vorliegende Indikation und erfülle nach MD-Bewertung nicht die Voraussetzungen einer ausnahmsweisen Leistung.

2. Begründung

Die Kasse verweist auf fehlende Zulassung, fehlende G-BA-Empfehlung, nicht ausreichende Evidenz und Wirtschaftlichkeit. Sie bietet eine erneute Beratung zu symptomatischer Therapie, Physiotherapie und Rehabilitation an.

3. Frist

Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Widerspruchsfrist 26.07.2026. Wegen Behandlungsslot am 18.07.2026 ist Eilrechtsschutz vorher erforderlich.

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Übernahme der Kosten für die Behandlung mit Neravexor gemäß Antrag der Universitätsmedizin Mainz.

2. Begründung

Die Mandantin leidet an einer schwerwiegenden, rasch progredienten Erkrankung. Standardtherapien wurden ausgeschöpft oder sind medizinisch nicht mehr erfolgversprechend. Die Klinik legt eine pathophysiologisch begründete und durch Studien- sowie Registermaterial gestützte Erfolgsaussicht dar. Die Kasse und der MD haben die notstandsähnliche Lage und die konkrete Prognose ohne Behandlung nicht ausreichend gewürdigt.

3. Nachreichung

Eine ergänzende fachärztliche Stellungnahme zur Dringlichkeit, Alternativlosigkeit und Nutzenwahrscheinlichkeit wird bis 08.07.2026 nachgereicht.

Eilantrag Sozialgericht, Arbeitsfassung

1. Antrag

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorläufig die Kostenübernahme für die Behandlung mit Neravexor entsprechend dem Therapieplan der Universitätsmedizin Mainz zu gewähren.

2. Anordnungsanspruch

Der Anspruch wird auf die außergewöhnliche Schwere, die fehlende Standardalternative, die fachärztlich begründete Erfolgsaussicht und die besondere Dringlichkeit gestützt. Der Schriftsatz muss offenlegen, dass die Evidenz nicht dem Regelfall entspricht, und erklären, warum dies bei der Seltenheit und Progression nicht zur Ablehnung führen darf.

3. Anordnungsgrund

Der Therapieslot am 18.07.2026 ist reserviert. Nach Klinikangabe drohen bei weiterem Schub irreversible Gang- und Sehverschlechterungen. Abwarten bis zur Hauptsacheentscheidung würde den möglichen Nutzen der Behandlung entwerten.

Folgeprüfung Krankengeld, Reha und Rente

1. Leistungsübersicht

Leyla Tunc ist seit 03.05.2026 arbeitsunfähig. Entgeltfortzahlung läuft voraussichtlich bis 14.06.2026, danach Krankengeld. Schwerbehindertenantrag wurde noch nicht gestellt. Reha war wegen instabiler Erkrankung zurückgestellt.

2. Rentenberaterliche Folgearbeit

Krankengeldfrist, Reha-Antrag, Schwerbehindertenrecht und Erwerbsminderungsrente müssen in einem Fristenblatt geführt werden. Der Off-Label-Eilantrag hat Vorrang, aber die medizinischen Unterlagen sollen so abgelegt werden, dass sie später für Reha, GdB und Erwerbsminderung wiederverwendbar sind.

Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie

Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz

Telefon 06131 17-0 | seltene-neuro@unimedizin-mainz.de

Bergland Krankenkasse

Leistungsmanagement Arzneimittel

Postfach 9042

65080 Wiesbaden

Mainz, 10. Juli 2026

Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor

Unser Zeichen: UM 26-NI-4471

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Größenbach wird seit Oktober 2024 wegen einer fortschreitenden neuroimmunologischen Erkrankung in unserer Spezialambulanz behandelt. Trotz zweier standardisierter Therapieversuche nahm die Gehstrecke von 420 Metern im Januar 2025 auf 85 Meter im Juni 2026 ab. Seit April benötigt sie außerhalb der Wohnung einen Rollstuhl. Schluckstörungen traten erstmals im Mai auf; eine Ernährungssonde ist derzeit noch nicht erforderlich.

Die bisherigen Medikamente wurden in ausreichender Dosis und Dauer gegeben. Unter dem zweiten Präparat kam es zu einer schweren Leberwerterhöhung, weshalb die Behandlung am 18. Februar beendet wurde. Das interdisziplinäre Fallboard besprach Neravexor am 24. Juni. Vorgesehen ist zunächst eine Dosis mit stationärer Überwachung und engmaschigen Laborwerten; eine weitere Gabe soll erst nach Auswertung des Verlaufs entschieden werden.

Der Bericht dokumentiert Befunde, Vorbehandlungen und den geplanten Ablauf. Die Patientin wurde darüber aufgeklärt, dass für ihre konkrete Erkrankung keine Zulassung besteht und die verfügbare Fallzahl klein ist. Sie und ihr Ehemann wünschen dennoch die erneute Prüfung. Befundkopien, Aufklärungsbogen und Laborverlauf sind beigelegt; die Originale verbleiben in der Krankenakte.

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Miriam Strauß

Oberärztin der Spezialambulanz

Anlage: 15 verlauf labor gehstrecke 2025 2026 (CSV-Export)